جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : هدى ابراهيم محمد مصطفى
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عابدين **العنوان :** ~~
رقم البطاقة : 25709022101122 **رقم التليفون :** 01121218078 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 02-09-1957 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هدى ابراهيم محمد مصطفى
National ID: 25709022101122

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

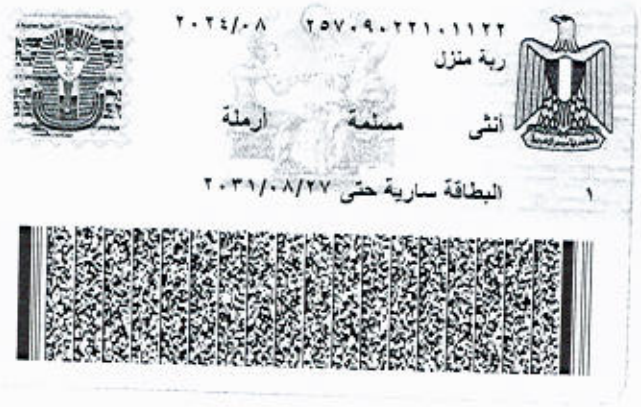
تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Pathology Report

Name: هدى إبراهيم محمد مصطفى **Age:63 years.**

Clinical data: Right retroareolar breast mass.

Specimen type: Conservative surgery and Axillary clearance

Date(Received): 28/2/2021 **Date(reported): /1/2021**

Lab. Number: 395/21 **Hospital Number:5515 /2020** نفقة دولة

Gross Description:

Two specimens were received:

1- WLE: measured 8x8x4cm, covering skin ellipse 4x2cm, cut section revealed ill-defined firm grey white 3.5x3.5x1.5cm, with least margin 0.9cm (superior).
2- Axillary clearance: fibrofatty tissue pieces 8x4cm collectively enclosing 15 nodules up to 1.5cm.

Microscopic Picture:

1- Histopathological examination of sections prepared reveals an infiltrating malignant epithelial growth made up of groups and sheets of pleomorphic hyperchromatic malignant ductal epithelial cells. Stromal desmoplasia is moderate. Cellular and nuclear atypia are moderate.
Intraduct component is 15% of comedo and non-comedo types.
Positive for lymphovascular emboli. Positive for perineural invasion.
Surgical margins are free.
2- Examination of the lymph nodes detected show metastatic deposits (2/15) with focal extracapsular extension.

Diagnosis:

Right breast, Conservative surgery and Axillary clearance:

- *Invasive Duct Carcinoma, Grade II with 15% Intraduct Component of comedo and non-comedo types.*
- *Positive for lymphovascular emboli.*
- *Positive for perineural invasion.*
- *Surgical margins are free.*
- *Lymph nodes metastases (2/15) with focal extracapsular extension.*
- *Stage pT2, pN1, pMx.*

ER
PR
her2

Prof. Dr. Lubna Omar
Dr. Mahmoud Kamel

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: هدي ابراهيم محمد مصطفي **MR. :** 8156	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is being treated for breast cancer with hormonal therapy, specifically Femara (letrozole) at a dose of 3 mg.

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : **Ali Adel**

يعتمد ,

Name : Hoda Ibrahim **Date :** 24-11-2020

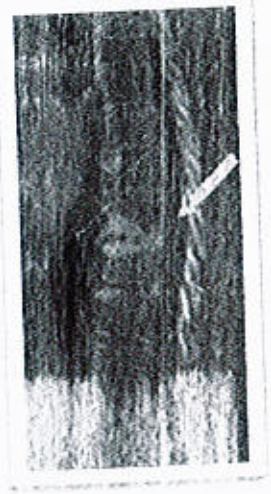
POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

1. **Chest:**

- Right breast , retro-areolar irregular enhancing mass lesion is seen measuring 3.3 x 1.7 x 3.7 cm. It seems inseprable form the nipple .
- Prominent right axillary LN is seen measuring 1.3 cm.
- Right major fissural nodule is seen measuring 4 mm, likely insignificant.
- Otherwise, no pulmonary masses , sizable nodules, consolidation or cavitary lesions.
- Prominent left para-tracheal LN is seen measuring 1.6 x 1 cm , for follow up.
- No evidence of pleural effusion.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. **Abdomen and pelvis:**

- Cirrhotic liver changes with enlarged left lobe, prominent interlobar fissure and nodular outline. No focal lesions.
- Prominent celiac and porto-caval LNs are seen, largest measures 1.6 x 0.9 cm, for follow up.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main oranches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Average size spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- No abdominal or pelvic collections.
- Degenerative changes of the spine, most appreciated at D9-10 level.
- Lytic osseous lesions are seen at D9 and L1 vertebral bodies, measuring 13 mm and 8 mm respectively.



OPINION:

- ***Right breast , retro-areolar irregular enhancing mass lesion inseprable form the nipple .***
- ***Prominent right axillary lymph node.***
- ***No pulmonary parenchymal metastatic deposits.***
- ***Cirrhotic liver changes. No hepatic metastatic deposits.***
- ***D9 and L1 vertebral osseous lytic lesions, for bone scan correlation.***

Dr. Peter Fahmy, MSc

Dr. Amr Farouk, MSc

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

IBRAHIM, HUDA, Patient ID: 123000524 DOB: 02-Sep-1957 Date: 09-Jan-2023

Patient Lastname: Ibrahim
Patient Firstname: HUDA
HIS Patient ID: 123000524
RIS Patient ID: 317888
Date of Birth: 02/09/1957

Procedure: 70030, Bone Scan
Medical Question:
Clinical Comment:

========== REPORT TEXT ==========
99mTc MDP Bone Scan Report(09/01/2023)
* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP Revealed:

" No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
" Exaggerated Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
" Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
" Both kidneys are visualized.
Conclusion:
" No definite evidence of active metastatic osseous deposits could be seen all over the surveyed skeleton.

Much Obliged
Dr. Mayadah Ashraf
Dr/Nahla Mamoun

========== REPORT TEXT ENDE ==========

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
هرمل، سابقا

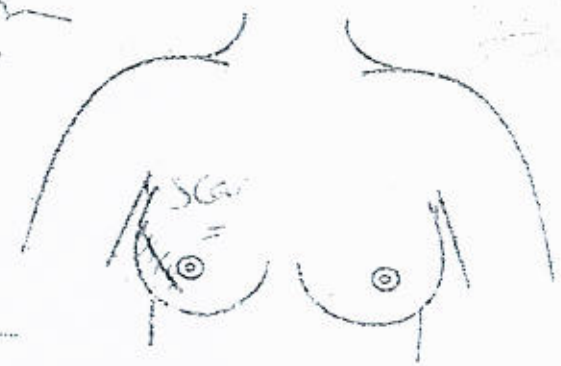
N.O.S : د. ابراهيم كبير
Age : 63
No.:

MDT FORM

Clinical data :

- DCIS -ve surgical history
- family history

cT2 N1



CBS & ALND.

IDC GIII pT2 N1 (3.5x3.5x1.5 cm), N2/15

Reason of discussion:

- Echo. → EF : 60 %
- labs.
- Bone scan

MDT Outcome and Plan:

for adjuvant chemo AC x4 then T x4

then adjuvant AI

Signature :

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]